

Grundlagen des Stufenmodells

Das Stufenmodell zur stationären Versorgung von Notfällen legt gemäß den Anforderungen nach § 136 c Absatz 4 Sozialgesetzbuch V für jede Stufe spezifische Vorgeben zu den folgenden Kriterien fest:

- Art und Anzahl von Fachabteilungen
- Anzahl und Qualifikation des vorzuhaltendes Fachpersonals
- Kapazität zur Versorgung von Intensivpatienten
- Medizinisch- technische Ausstattung
- Strukturen und Prozesse der Notfallaufnahmen

Eine Fachabteilung liegt dann vor, wenn folgende Voraussetzungen erfüllt sind:

- Eine fachlich unabhängige, abgrenzbare und organisatorisch eigenständige Organisationseinheit am Standort des Krankenhauses
- Angestellte Ärzte des Krankenhauses sind der Fachabteilung zugeordnet, und haben entsprechende Qualifikationsnachweise der Weiterbildungsordnung der Ärztekammer
- Ein angestellter Facharzt des Krankenhauses mit den entsprechenden Qualifikationen ist 24 Stunden am Tag/ 7 Tage die Woche innerhalb von 30 Minuten am Patienten verfügbar
- Das Krankenhaus hat einen entsprechenden Versorgungsauftrag für die Fachabteilung, sofern der Krankenhausplan des jeweiligen Landes oder ein Versorgungsauftrag nach § 109 SGB V vorsieht

Allgemeine Anforderungen an alle Stufen

- Die Vorgeben sind von den Krankenhäusern zu jeder Zeit am Standort zu erfüllen, um der jeweiligen Stufe zugeordnet zu werden
- Die Notfallversorgung der Notfallpatienten findet im Krankenhäusern, die an einer Stufe des Systems von Notfallstrukturen teilnehmen, überwiegend in einer zentralen Notaufnahme, die immer am Krankenhausstandort vorzuhalten ist, statt
- Krankenhäuser, die an einer Stufe des Systems von Notfallstrukturen teilnehmen, sollen zur Versorgung von ambulanten Notfällen eine Kooperationsvereinbarung mit den zuständigen Kassenärztlichen Vereinigung schließen

Anforderungen an die Basisnotfallversorgung

Art und Anzahl der Fachabteilungen

- Krankenhäuser verfügen mindestens über die Fachabteilungen Chirurgie, Unfallchirurgie und Innere Medizin am Standort

Anzahl und Qualifikation des vorzuhaltenden Fachpersonals in der Basisnotfallversorgung

- Krankenhäuser stellen mindestens folgende Qualifikationen des Fachpersonals sicher
- Jeweils ein für die Notfallversorgung verantwortlicher Arzt und eine Pflegekraft, die fachlich, räumlich und organisatorisch eindeutig der Versorgung von Notfällen zugeordnet sind und im Bedarfsfall in der ZNA verfügbar sind. Der genannte Arzt muss die Zusatzbezeichnung Klinische Notfall- und Akutmedizin besitzen
- Pflegekraft verfügt über die Zusatzbezeichnung Notfallpflege
- Jeweils ein Facharzt der Bereiche Innere Medizin, Chirurgie und Anästhesie muss innerhalb von 30 Minuten verfügbar sein
- Genanntes Personal nimmt regelmäßig an fachspezifischen Fortbildungen für Notfallmedizin teil

Kapazität zur Versorgung von Intensivpatienten in der Basisnotfallversorgung

- Krankenhäuser halten mindestens sechs Intensivbetten vor, von denen mindestens drei Betten mit Beatmungskapazität ausgestattet sind

Medizinisch- technische Ausstattung in der Basisnotfallversorgung

- Krankenhäuser verfügen über die für die Durchführung von Diagnostik und Therapie nach aktuellen medizinischen Standard erforderliche medizinisch-technische Ausstattung
 - Schockraum
 - 24-h-verfügbare computertomographische Bildgebung

Strukturen und Prozesse der Notaufnahmen in der Basisnotfallversorgung

- Krankenhäuser erfüllen alle der folgenden Strukturen und prozeduralen Voraussetzungen zur Aufnahme von stationären Notfällen
 - Aufnahme erfolgt überwiegend in der zentralen Notaufnahme
 - Es kommt ein strukturiertes, validiertes System zur Behandlungspriorisierung bei der Erstaufnahme von Notfallpatienten zur Anwendung
 - Alle Notfallpatienten des Krankenhauses erhalten spätestens nach 10 Minuten nach Eintreffen in der Notaufnahme eine Einschätzung der Behandlungspriorität
 - Aussagekräftige Dokumentation ist absolut verpflichtend

Anforderungen an die erweiterte Notfallversorgung

Zusätzlich zu den Anforderungen an die Basisnotfallversorgung sind für die erweiterte Notfallversorgung folgende Kriterien:

Art und Anzahl der Fachabteilungen in der erweiterten Notfallversorgung

- Krankenhäuser verfügen zusätzlich zu den Ursachen der Basisversorgung über insgesamt vier der in Kategorie A und Kategorie B benannten Fachabteilungen
- Mindestens zwei davon sind aus Kategorie A
 - Kategorie A
 - Neurochirurgie, Neurologie, Orthopädie und Unfallchirurgie, Innermedizin und Kardiologie, Innere Medizin und Gastroenterologie, Gynäkologie und Geburtshilfe
 - Kategorie B
 - Innere Medizin und Pneumologie, Kinder- und Jugendmedizin, Kinderkardiologie, Neonatologie, Kinderchirurgie, Gefäßchirurgie, Thoraxchirurgie, Urologie, HNO, Innere Medizin und Hämatologie und Onkologie

Anzahl und Qualifikation des vorzuhaltenden Fachpersonals in der erweiterten Notfallversorgung

- Siehe Basisversorgung

Kapazität zur Versorgung von Intensivpatienten in der erweiterten Notfallversorgung

- Krankenhäuser halten eine Intensivstation mit mindestens 10 Intensivbetten, die auch zur Versorgung beatmeter Patienten ausgestattet sind
- Aufnahmebereitschaft auch für beatmungspflichtige Intensivpatienten innerhalb von 60 Minuten nach Krankenhausaufnahme

Medizinisch. Technische Ausstattung in der erweiterten Notfallversorgung

- Krankenhäuser verfügen zusätzlich zu den Vorgaben der Basisversorgung grundsätzlich zu jeder Zeit über folgende Ausstattung am Standort
 - Kontinuierliche Möglichkeit einer notfallendoskopischen Intervention am oberen Gastrointestinaltrakt
 - Kontinuierliche Möglichkeit der perkutanen koronaren Intervention
 - MRT
 - Ausstattung zur Primärdiagnostik des Schlaganfalls und der Möglichkeit zur Einleitung einer Initialtherapie (Fibrinolyse oder interventionelle Therapie)
- Es ist eine Hubschrauberlandestelle vorzuhalten

Strukturen und Prozesse der Notfallaufnahme in der erweiterten Notfallversorgung

- Krankenhäuser erfüllen zusätzlich zu den Vorgaben der Basisversorgung folgende Voraussetzungen

- Die zentrale Notaufnahme hat eine organisatorisch der Notaufnahme angeschlossene Beobachtungsstation von mindestens sechs Betten

Anforderungen an die umfassende Notfallversorgung

Zusätzlich zu den Anforderungen an die Basisnotfallversorgung sind für die umfassende Notfallversorgung folgende Kriterien:

Art und Anzahl der Fachabteilungen in der umfassenden Notfallversorgung

- Krankenhäuser der umfassenden Notfallversorgung verfügen zusätzlich zu den Vorgaben der Basisversorgung über insgesamt sieben Fachabteilungen aus der Kategorie A und Kategorie B
 - Mindestens fünf sind aus der Kategorie A
 - Neurochirurgie, Neurologie, Orthopädie und Unfallchirurgie, Innermedizin und Kardiologie, Innere Medizin und Gastroenterologie, Gynäkologie und Geburtshilfe
 - Kategorie B
 - Innere Medizin und Pneumologie, Kinder- und Jugendmedizin, Kinderkardiologie, Neonatologie, Kinderchirurgie, Gefäßchirurgie, Thoraxchirurgie, Urologie, HNO, Innere Medizin und Hämatologie und Onkologie

Anzahl und Qualifikation des vorzuhaltenden Fachpersonals in der umfassenden Notfallversorgung

- Siehe Basisversorgung

Kapazität zur Versorgung von Intensivpatienten in der umfassenden Notfallversorgung

- Krankenhäuser halten mindestens 20 Intensivbetten vor, die auch zur Versorgung beatmeter Patienten ausgestattet sind
- Aufnahmebereitschaft auch für beatmungspflichtige Patienten innerhalb von 60 Minuten nach Krankenhausaufnahme

Medizinisch- technische Ausstattung in der umfassenden Notfallversorgung

- Krankenhäuser verfügen zusätzlich zu den Vorgaben der Basisversorgung grundsätzlich zu jeder Zeit über folgende Ausstattung am Standort
 - Kontinuierliche Möglichkeit einer notfallendoskopischen Intervention am oberen Gastrointestinaltrakt
 - Kontinuierliche Möglichkeit der perkutanen koronaren Intervention
 - MRT

- Ausstattung zur Primärdiagnostik des Schlaganfalls und der Möglichkeit zur Einleitung einer Initialtherapie (Fibrinolyse oder interventionelle Therapie)
- Es ist eine Hubschrauberlandestelle vorzuhalten
 - Patientenverlegungen auf dem Luftweg sind ohne Zwischentransporte möglich

Strukturen und Prozesse der Notfallaufnahme in der umfassendes Notfallversorgung

- Krankenhäuser erfüllen zusätzlich zu den Vorgaben der Basisversorgung folgende Voraussetzungen
 - Die zentrale Notaufnahme hat eine organisatorisch der Notaufnahme angeschlossene Beobachtungsstation von mindestens sechs Betten